Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Márcio Veras Vidor, 10 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110160 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent1jij@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5133276-48.2021.8.21.0001/RS

REQUERENTE: BRENNO KAUA VIEIRA FERNANDES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Resumo: Criança. Pedido de remédio não fornecido pelo SUS. Aripiprazol. Requisitos necessários: a) demonstrar que a criança precisa e é imprescindível o medicamento; b) dificuldade financeira do autor em adquirir o fármaco; c) o remédio deve estar registrado na ANVISA. Requisitos preenchidos. Pedido concedido.

RELATÓRIO

BRENNO KAUA VIEIRA FERNANDES, criança, representada por sua genitora, ajuizou a presente "ação ordinária com pedido de tutela antecipada" contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, afirmando ter sido diagnosticado com AUTISMO INFANTIL (CID 10: F 84.0) e RETARDO MENTAL MODERADO (CID 10: F 71.1). Em função disso, necessita fazer uso do medicamento ARIPIPRAZOL 10MG, 30 comprimidos ao mês, de forma contínua e por período indeterminado. Aduziu que sua família não tem condições financeiras para custear o tratamento e que, solicitada a medicação ao Estado, este deixou de fornecê-la. Pediu a tutela antecipada para que o requerido seja compelido a fornecer o medicamento, e, ao final, a procedência da ação. Acostou documentos (evento 1, INIC1).

A tutela antecipada foi deferida, sendo aberto o prazo de 03 dias para que os reús fornecessem a medicação, sob pena de bloqueio de valores (evento 4, DESPADEC1).

Em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 70084442060, que debatia a competência para julgar os casos em que se discute o direito à saúde de crianças e adolescentes, o processo foi suspenso, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil (evento 21, DESPADEC1).

Citado, o Município apresentou contestação. Arguiu sua ilegitimidade passiva, pois o medicamento Aripiprazol não faz parte da lista de medicamentos da rede pública, sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação. Requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do processo em relação ao município, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, e, no mérito, pela improcedência da ação (evento 41, CONT2).

Postulado o bloqueio de valores (evento 42, PET1) esse foi deferido (evento 44, DESPADEC1), sendo expedido alvará (evento 47, ALVLEVANT1).

As contas foram prestadas (evento 53, NFISCAL3).

O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação. Sustentou ser da competência do Ministério da Saúde a inserção de novas tecnologias no âmbito da rede pública, sendo necessário, portanto, a inclusão da União no polo passivo da presente ação, pois o medicamento requerido não está na lista do SUS. Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar, determinando a emenda à inicial com a inclusão da União no polo passivo da demanda, com posterior remessa dos autos a Justiça Federal (evento 57, CONT1).

As contas foram homologadas, oportunidade em que as preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento da União arguidas pelo Município de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul (evento 41, CONT2 e evento 57, CONT1) foram afastadas (evento 64, DESPADEC1).

Intimadas, as partes informaram não ter interesse na produção de novas provas (evento 69, PET1, evento 71, PET1 e evento 72, PET1).

O Ministério Público opinou pelo julgamento de procedente a ação, tornando definitiva a liminar restabelecida (evento 4), condenando-se o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE ao fornecimento do fármaco Aripiprazol, 10 mg, 60 comprimidos mensais, por tempo indeterminado, em favor de BRENNO KAUÃ VIEIRA FERNANDES, com reavaliações periódicas que atestem a necessidade da permanência do tratamento (evento 75, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Julgamento antecipado

Julgo o processo de forma antecipada, pois não vieram requerimentos de outras provas, incidindo o art. 355, I, do Código de Processo Civil, estando o feito apto para julgamento.

2. Competência

Trata-se de ação que objetiva o fornecimento de medicamento não disponibilizado pela rede pública.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão que ainda não transitou em julgado (pode vir a ocorrer algum esclarecimento, por exemplo, em eventuais novos embargos de declaração), assim se posicionou:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.* ***RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.*** *DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.* ***O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.* ***As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.*** *Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.4. Embargos de declaração desprovidos (EMB.DECL.* ***NO RECURSO*** *EXTRAORDINÁRIO 855.178 SERGIPE RELATOR MIN. LUIZ FUX, REDATOR PARA O ACÓRDÃO MIN. EDSON FACHIN).*

a interpretação do julgado, cito recente posicionamento do Ministro André Mendonça, de setembro de 2022, conforme se depreende do inteiro teor da decisão na Reclamação nº 55681 / MG:

> *"DECISÃO RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. VIOLAÇÃO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.*
>
> *1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível) — MG, no processo nº 5007825-29.2020.8.13.0079, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.*
>
> *2. O reclamante narra que, na origem, Divino Benjamim de Souza ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com vistas a obter o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS para a doença que acomete o ora beneficiário (Vielut Lutein ou Totavit ou Luvis ou Neovit Max e Denatran colírio – Latanoprosta). Informa que o Juízo a quo não incluiu a União no polo passivo da demanda. Menciona que recorreu à Turma Recursal, defendendo a necessidade de participação do ente federal na lide.*
>
> *3. Noticia que o Tribunal reclamado manteve a decisão de não inclusão da União no polo passivo. Informa acerca do recurso extraordinário interposto, o qual teve seu seguimento negado sob o fundamento de correta aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte. Relata que interpôs agravo regimental, demonstrando a dissonância existente entre as conclusões do acórdão da Turma Recursal e a íntegra do acórdão normativo deste Supremo, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 855.178-RG/SE, resultando na violação do art. 196 da CRFB. Observa que o referido agravo teve seu provimento negado.*
>
> *4. Sustenta que o Tribunal reclamado não observou a tese firmada por esta Suprema Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE – Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Alega que não se mantém, do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão.*
>
> *5. Requer seja julgado procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja outra proferida em substituição, com vistas a incluir a União no polo passivo da demanda de origem. É o relatório. Decido.*
>
> *6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. "l", da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).*
>
> *7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.*
>
> *8. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), no que afastada, pelo Juízo reclamado, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.*
>
> *9. Sem razão a parte reclamante. Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, dos respectivos embargos de declaração: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente." (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos). "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,*

isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).

10. Não há, no comando judicial transcrito, dever de inclusão da União (ou de qualquer outro ente federado), salvo em relação ao fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, conforme item 3 da ementa acima transcrita, entendimento que, aliás, harmoniza-se com o Tema nº 500 do ementário da Repercussão Geral desta Corte (RE nº 657.718-RG/MG).

11. Na decisão reclamada, por sua vez, trata-se do medicamento Latanoprosta (Vielut Lutein ou Totavit ou Luvis ou Neovit Max e Denatran colírio), o qual é devidamente registrado na Anvisa.

12. Em relação ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, há julgados das duas Turmas desta Suprema Corte negando seguimento a reclamações cujas decisões não contenham teratologia ou manifesto descumprimento da tese fixada no julgado paradigma. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl nº 45.030-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos). "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 793, sob o fundamento de que o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a União é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793 e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento." (Rcl nº 49.909-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos). 13. Menciono, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 48.492-AgR/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/10/2021, p. 03/11/2021); Rcl nº 49.461-AgR/MS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/12/2021, p. 23/02/2022); e Rcl nº 51.373/MS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/02/2022, p. 15/02/2022). 14. Frise-se que, na estreita via da reclamação, o confronto do ato atacado com o que decidido em tema de repercussão geral deve se dar a partir dos delimitados contornos do firmado por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível cotejar eventual obiter dictum ou ratio decidendi do julgado paradigma, mesmo porque esta Corte não tem acolhido, em vasta jurisprudência, a denominada transcendência ou irradiação dos motivos determinantes.

*15. **A partir dos contornos claramente fixados por este Pretório Excelso, ao estabelecer, de forma cogente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo das demandas na única hipótese de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, não há como alargar tal obrigação para as situações a versarem sobre medicamentos não padronizados ou incorporados pelo SUS**.*

*16. **Em análise do julgamento do RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, constata-se que a Corte se debruçou sobre outras situações, tendo optado por firmar exclusivamente tese concernente apenas à referida hipótese, não constatada no presente caso, em que consta o registro do medicamento**.*

17. Por fim, é importante assentar que, no tema em questão, o cotejo objetivo entre a decisão reclamada e o firmado no paradigma de repercussão geral, próprio da via da reclamação e consolidado nesta Suprema Corte, revela, ainda, conclusão direcionada à necessária preocupação com a consecução do acesso à Justiça, especialmente pelos mais vulneráveis, comumente atendidos pelas Defensorias Públicas estaduais, e com a devida efetivação do direito à saúde.

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Ministro ANDRÉ MENDONÇA Relator.

Ademais, está em andamento Incidente de Assunção de Competência no Superior Tribunal de Justiça envolvendo a questão da inclusão ou não da União, conforme se pode verificar:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.
1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária.
*3. **Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a***

inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.
4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.

No referido IAC o STJ definiu, em caráter provisório, **que nestes casos a competência deve ser mantida provisoriamente com a Justiça Estadual nos conflitos de competência com a Justiça Federal, conforme se pode verificar: "....** d) **havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento**" (vide IAC no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 187.276 - RS -2022/0097613-9-, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 31/05/2022).

Ou seja, se o processo for remetido para a Justiça Federal, voltará com base na decisão do STJ.

Por fim, dentro da Justiça Estadual, assinalo que os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70084442060 (IRDR 23) e nº 70084438670 (IRDR 24) indicam que a competência é da Vara da Infância e da Juventude.

3. Outras preliminares

As preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento da União arguidas pelo Município de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul (evento 41, CONT2 e evento 57, CONT1) já foram afastadas (evento 64, DESPADEC1), razão pela qual, passo ao exame do mérito.

4. Mérito

Conforme o art. 227 da CF, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à vida e à saúde:

> **Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.**
> **§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:**
> **(…).**

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas:

> **Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.**

O fornecimento da medicação foi indeferido pela Secretaria Estadual de Saúde, pois o fármaco não integra a lista do SUS (evento 1, OUT13).

O caso se insere na hipótese do Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 25/04/18, assim ementado:

> ***ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora***
> ***de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os 4. casos de outras alternativas terapêuticas. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015*** *(REsp 1657156/RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0025629-7, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/04/2018).*

Portanto, pela decisão superior, são necessários três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.

E os três requisitos foram atendidos pela parte autora.

A um, a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública, sendo presumida a hipossuficiência do autor, a qual não foi contestada pelo demandado.

A dois, o medicamento está registrado na ANVISA, tanto é assim que pode ser encontrado em qualquer farmácia conforme demonstram os orçamentos juntados durante toda fase instrutória.

A três, a requerente comprovou a imprescindibilidade do medicamento, pois já utilizados os medicamentos disponibilizados pela rede pública, sem controle da agitação, com aumento da heteroagressividade com violência direcionada às figuras parentais de forma cotidiana e insônia (evento 1, ATESTMED8).

Restou atestado no laudo do evento 1, LAUDO14 a urgência na ingestão do medicamento, em razão das agitações psicomotoras graves, com riscos para integridade física de outros e se si mesmo, com possível necessidade de internação.

Assim, deve ser acolhido o parecer do Ministério Público (evento 75, PROMOÇÃO1), prosperando o pedido inicial.

Cito jurisprudência:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. FORNECIMENTODE MEDICAMENTO. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAR ATENDIMENTO. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Magistrado é o destinatário legal da prova, a quem compete avaliar sua necessidade para dirimir o caso concreto. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Inocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto, tendo em vista que o material contido do caderno probatório é suficiente para sanar a controvérsia, não sendo imprescindível produção probatória complementar. 2. A assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado Iato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal.* ***3. Prova dos autos hábil a demonstrar que o medicamento cujo fornecimento é postulado pela parte autora é indicado para o seu quadro clínico de autismo infantil (CID 10: F 84.0). Laudo médico elaborado pelo médico que acompanha o demandante que atestou a ausência de resposta à medicação disponível junto ao SUS.*** *4. Desnecessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que, segundo o entendimento mais recente adotado por esta Câmara, somente é necessária a inclusão da União no polo passivo quando a medicaçãosolicitada não tenha sido aprovada pela ANVISA, o que não é o caso. 5. Devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em face da ausência de confusão patrimonial no arbitramento. Redução da verba sucumbencial devida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEP pelo Município de Gravataí PRELIMINAR AFASTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084499847, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 19-10-2020)*

Saliento que a decisão será de concessão de Aripiprazol, ou seja, na forma da Denominação Comum Brasileira, e não necessariamente no nome comercial, visto que não há indicação médica da impossibilidade de uso do fármaco na forma genérica.

Destaco que, em caso de necessidade de bloqueio de valores, esse se dará na proporção de 50% para cada ente público, diante do entendimento jurisprudencial de solidariedade entre os entes federativos, bem como em razão de o fármaco requerido não fazer parte das listas dos insumos/medicamentos disponibilizados pelo SUS, mas com possibilidade de busca de ressarcimento perante a União, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal: "... *a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro*" (Emb. Decl. no Recurso Extraodinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Redator para o acórdão Min. Edosn Fachin).

DECISÃO

Ante o exposto, torno definitiva a antecipação de tutela e julgo **procedente** a ação para condenar o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE a fornecerem à criança B.K.V.F. o medicamento ARIPIPRAZOL 10MG, 01 comprimido à noite, totalizando 30 comprimidos mensais (evento 1, RECEIT12), ficando extinto o processo com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Deverão ocorrer reavaliações periódicas, em até seis meses cada, para verificação da manutenção da necessidade e quantidade do medicamento.

Sem custas (art. 141, §2º, do ECA). No tocante aos honorários advocatícios, conforme Súmula 421, STJ,"os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". Contudo, em relação ao Município, cabível a condenação em verba honorária, uma vez que ausente a confusão entre credor e devedor. Assim, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 500,00 em favor do FADEP.

Em face da inexistência de juízo de admissibilidade (art. 1010, § 3º, do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, ao Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL ENGLERT BARBOSA, Juiz de Direito**, em 5/10/2022, às 17:10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10026462812v10** e o código CRC **0320f796**.